Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vfaz@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000578-45.2023.8.21.5001/RS

AUTOR: SOLANGE TEIXEIRA DA ROSA MARONEZ

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **SOLANGE TEIXEIRA DA ROSA MARONEZ** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL** visando ao fornecimento do medicamento OPDIVO (NIVOLUMABE) em razão do seu diagnóstico de câncer de esôfago avançado (CID 10 – C15.9). Requereu, em antecipação de tutela, a concessão do fármaco pleiteado ou, alternativamente, bloqueio de valores. No mérito, pugnou pela procedência do pedido (evento 1, INIC1).

A 1ª Vara Cível do Foro Regional do Sarandi ordenou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública (evento 3, DESPADEC1).

Deferida a gratuidade da justiça e requisitadas as razões do indeferimento administrativo do pedido (evento 9, DESPADEC1).

O demandado comunicou que *"o medicamento foi negado porque não há previsão de cobertura pelo Instituto"* (evento 14, OFIC1).

Requisitada nota técnica (evento 20, DESPADEC1), a qual foi emitida com conclusão favorável (evento 23, NOTATEC1).

A parte autora requereu a concessão da tutela de urgência (evento 24, PET1).

Concedida a antecipação de tutela (evento 26, DESPADEC1).

O demandado noticiou o cumprimento da decisão e a remessa de Guia de Atendimento ao Hospital Ernesto Dornelles (evento 31, OFIC1).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em síntese, que o medicamento postulado não está previsto no Protocolo Oncológico adotado pelo IPE-Saúde para o tratamento da enfermidade apresentada. Requereu a improcedência do pedido (evento 37, CONT1).

A parte autora ofertou réplica (evento 42, RÉPLICA1).

Intimadas (evento 47, DESPADEC1), a parte autora renunciou ao prazo para manifestação (Evento 48) e a parte ré informou não ter outras provas a produzir (evento 53, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (evento 56, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Passo a fundamentar.

A Constituição Federal, no *caput* do artigo 6º, assegurou o direito fundamental à saúde. No artigo 196, por sua vez, consagrou-a como direito de todos e dever do Estado, preceituando que:

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Dito isso, observo que a negativa do IPE-Saúde em fornecer o tratamento postulado baseou-se na seguinte justificativa (evento 14, PROCADM2):

> Indeferimento da solicitacao 09/11/2022 Oper 999999
>
> Tratamento não previsto nas recomendações técnicas

Entretanto, verifico que os documentos coligidos aos autos evidenciam que a autora foi diagnosticada com câncer de esôfago avançado (CID 10 – C15.9).

Nesse sentido, o laudo médico anexado concomitante à inicial revelou o diagnóstico de câncer da autora e a imprescindibilidade do uso de Nivolumabe (evento 1, LAUDO6):

A Sra Solange Teixeira Maronez de 60 anos, RG 9030057138 , CPF 501434090-34 teve o diagnóstico de Câncer de esôfago localmente avançado, CID -10 C15.9. Fez tratamento neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia concomitantes seguido de cirurgia- esofagectomia 20/09/2022. O laudo anatomopatológico mostrou que o paciente apresentava doença residual após o tratamento, o que significa que a quimio e radioterapia não foram suficientes para erradicar a neoplasia e ainda restavam focos de tumor no esôfago ressecado. Essa condição aumenta muito o risco da doença retornar e se tornar incurável fazendo com que a paciente venha a falecer desta causa. Deste modo, está indicado um tratamento complementar com imunoterapia com uma droga denominada Nivolumab, conforme resultados do estudo de fase III CheckMate 577.

Nivolumabe deverá ser usado na dose de 240 mg endovenoso a cada 2 semanas por 16 semanas (8 doses) e posteriormente deverá ser usado na dose de 480 mg a cada 4 semanas até completar 1 ano de tratamento.

Este tratamento com imunoterapia aumenta a sobrevida livre de doença de 11 meses alcançada no tratamento padrão (placebo-/ observação) para 22,4 meses com Nivolumabe, ou seja duplicou o tempo que os pacientes ficam livres do câncer. O uso de Nivolumabe é urgente e insubstituível.

Ademais, a nota técnica concluiu favoralmente ao tratamento postulado pela autora (evento 23, NOTATEC1):

Tecnologia: NIVOLUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando que a indicação do tratamento está de acordo com o recomendado pelas diretrizes de tratamento para a patologia da autora;
Considerando que a autora se enquadra no perfil de paciente que obteve benefício com o uso do medicamento;
Conclui-se que há elementos técnicos na literatura médica que amparam a indicação do nivolumab para o manejo do caso em tela.

Por tais razões, foi concedida a antecipação de tutela com a seguinte deliberação (evento 26, DESPADEC1):

*Ante o exposto, **DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA** formulado e determino ao **IPE-Saúde** que, no prazo de 03 (três) dias úteis, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Nivolumabe** nos termos da prescrição e laudo médicos (evento 1, RECEIT8 e evento 1, LAUDO6), os quais deverão ser atualizados pela parte autora semestralmente.*

Assim, diante das alegações da demandante, corroboradas pela documentação juntada aos autos - especialmente os laudos médicos, devidamente fundamentados na justificativa da indicação de tratamento -, está demonstrada a necessidade de uso do fármaco.

Não obstante, é imprescindível considerar que o médico assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar o medicamento com melhor eficácia para tratar a autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo médico assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar prevista nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga, ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, visto que eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE STENT DIVERSOR DE FLUXO PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA, CREDENCIADA AO IPERGS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA DO PLANO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Caso em que o procedimento postulado não se inclui dentre os tratamentos não cobertos pelo IPERGS – arts. 41 e 42 da Resolução nº 21/79 –, portanto, não há falar em descabimento da pretensão da parte autora, tampouco afronta aos princípios da isonomia, igualdade e da legalidade. Portanto, falta amparo legal à recusa da autarquia

previdenciária em custear o procedimento, materiais prescritos por médico vinculado ao Plano de Assistência Médica. (...) À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70079189999, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 12-12-2018).

Dessa maneira, evidenciado o direito da demandante - enquanto beneficiária - de postular ao IPE-Saúde, autarquia do Estado responsável pelo sistema de saúde, o fornecimento da medicação postulada, necessária ao tratamento de sua patologia.

Por conseguinte, levando em conta o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os laudos médicos atestando a imprescindibilidade do fornecimento do fármaco requerido, imperioso o acolhimento do pleito apresentado na inicial.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE o pedido** formulado por Solange Teixeira da Rosa Maronez em face do IPE-SAÚDE - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela antecipada (evento 26, DESPADEC1), determinando o fornecimento do medicamento **Nivolumabe,** na dosagem e na forma prescritas pelo médico.

Ratifico a gratuidade da justiça à parte autora, já deferida anteriormente (evento 9, DESPADEC1), nos termos do artigo 98 do CPC.

Isento o demandado do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei 14.634/14.

Condeno o IPE-Saúde ao pagamento das despesas processuais, nos termos do artigo 84 do CPC, bem como dos honorários advocatícios ao procurador da parte autora, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/20211, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Caso seja interposto recurso de apelação, processe-se conforme os trâmites legais e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Havendo saldo remanescente nos autos, expeça-se alvará em favor de quem for de direito.

Com o trânsito em julgado, proceda-se à baixa do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA DANTAS BOBSIN, Juíza de Direito**, em 28/7/2023, às 17:55:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10043073064v7** e o código CRC **3386c2e9**.